МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 12 дугаар сарын 30 № 3/46 Улаанбаатар хот

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ
ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ Л.НАСАНЦЭНГЭЛ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 7.1.8, 7.1.10 дахь хэсэг, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 18.1.2, 18.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус удирдлага болгон Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв (СЭМҮТ)-д эмчлүүлэгчид, эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд (эмч, ажилтнууд)-ын Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг 2021 оны 10 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд шалгалаа. Шалгалтын хүрээнд СЭМҮТ-ийн удирдлагад шалгалтын зорилго, удирдамжид тусгагдсан асуудлыг танилцуулах, тулгамдсан асуудлыг сонсох уулзалтыг 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион явуулж, шалгалтын урьдчилсан дүнг 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр, шалгалтын эцсийн дүнг 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр төвийн удирдлагуудад танилцууллаа.

Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаарх төрийн бодлого СЭМҮТ-ийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа байдал; эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх; халдашгүй чөлөөтэй байх, хэрцгий, хүнлэг бус харьцаа, шийтгэлээс ангид байх, мэдээлэл авах зэрэг эмчлүүлэгчийн хувийн халдашгүй байдлын эрх; эмчлүүлэгчийн нийгмийн оролцоо, харилцаа, хэвийн амьдрах боломжийг дэмжих үйл ажиллагаа; эмчлүүлэгч хууль зүйн туслалцаа авах, төвийн удирдлага, төрийн бусад байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах эрх, СЭМҮТ-ийн эмч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах эрх зэрэг 6 чиглэлийн 32 асуудалд хяналт тавилаа.

Комиссоос СЭМҮТ-ийн хүний эрхийн нөхцөл байдалд 2007, 2016 онд шалгалт хийсэн байна. 2016 онд явуулсан шалгалтын дагуу тус төвд хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2016 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 3/13 дугаар шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулсан талаар 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/118 дугаар албан бичгээр хариу ирүүлж байсан юм. Энэ удаагийн шалгалтаар Комиссоос СЭМҮТ-д явуулсан шалгалтуудаас хойш өөрчлөгдсөн нөхцөл байдал, шалгалтын үр дүн тогтвортой байгаа эсэхэд мөн хяналт тавилаа.

Ажлын хэсэгт Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн Эмчилгээний чанар хариуцсан улсын ахлах байцаагч Т.Улзмаа ажиллаж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, хүрэлцээ, хадгалалт, тасгуудын үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал, үйлчлүүлэгч, эмчлүүлэгчийг хүлээн авах, эмчлэх, тусгаарлах болон эргэлтийн өрөөний зай талбай, эрүүл ахуйн нөхцөл байдал, халдваргүйжүүлэлт, хоол боловсруулах, бэлтгэх байдал, хоол, хүнс, ундны усны хангалт, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэх, эмийн гаж нөлөөг бүртгэж, хяналт тавьж байгаа

байдал, коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар авсан арга хэмжээ зэрэг шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудад хяналт тавьсан болно. Энэ хүрээнд СЭМҮТ-д хүргүүлсэн Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын ахлах байцаагчийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02-03-158/635 дугаар зөвлөмж нь энэ шаардлагын бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

Шалгалтыг ажиглалт хийх, эмчлүүлэгч, эмч, ажилтнуудтай ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргаар явууллаа. Нөхцөл байдлыг тодруулах, баталгаажуулах зорилгоор эмчлүүлэгч, эмч, ажилтнуудаас санал асуулга авсан. Шалгалтын явцад цугларсан, анхаарал татахуйц мэдээллийг нягтлах зорилгоор Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн газар, тус газрын гуравдугаар хэлтэс, Цэргийн төв эмнэлгийн Эмгэг судлал, шүүх эмнэлгээс баримт гаргуулж, албан хаагчаас тайлбар авсан болно.

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд СЭМҮТ-ийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагаанд үлэмж ахиц дэвшил гарчээ. 2018-2020 онд Засгийн газраас нийт 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хуваарилуулж, төвийн барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулжээ. СЭМҮТ нь төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн байгууллага болохынхоо хувьд сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаарх төрийн бодлогыг тодорхойлох, сэтгэцийн эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ, сургалт, эрдэм шинжилгээг хөгжүүлэхэд манлайлах үүрэгтэй оролцож байна. Ялангуяа, аутизм өвчнийг эрт оношлох аргачлалыг нэвтрүүлэх, шинэ төрлийн мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд оруулах, гаж нөлөө ихтэй эмийг бүртгэлээс хасуулах, поликлиникийг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн дуудлага хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх 24 цагийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх, сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн эрхийг хүндэтгэх, хүн ёсоор хандах нийгмийн хандлага, соёлыг төлөвшүүлэх талаар явуулдаг сургалт сурталчилгааны ажлуудын үр дүн, ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэж байна.

Шалгалтаар дараах хүний эрхийн зөрчил, цаашид хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдал тогтоогдлоо. Үүнд:

1. **Төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд эмчлүүлэгчийг үл хайхрах, хүнлэг бус, хэрцгий хандах хүний эрхийн зөрчил гарч байна.** Ялангуяа удаан хугацаагаар эмчлүүлж, асруулж байгаа сэтгэцийн хурц солиоролтой хүмүүсийг үл хайхрах, хүнлэг бус хандах зөрчил гарч байгааг эмчлүүлэгчид ярьж байв. Асрамжийн клиникийн дарга Я.С нь согтуурсан үедээ асруулагчдыг 2-3 удаа зодсон, хэл үгээр доромжилдог, зарим сувилагч, туслах сувилагч нар тайван бус эмчлүүлэгчийг өлгийдөж, даруулга хийхдээ нүүрийг нь хавдтал алгаддаг, эмчлүүлэгчийг нэг газраас нөгөөд хөтөлж хүргэхдээ гарыг чанга базаж, хөхрүүлдэг тухай мэдээлсэн. Тус мэдээлэл бодитой эсэхийг нэг бүрчлэн тогтоох боломжгүй боловч зөрчлийн мэдээллийг холбогдох байгууллага, эх сурвалжаас нягталсны үндсэн дээр дээрх дүгнэлтэд хүрч байна. Тухайлбал 2020 оны 03 дугаар сард сэтгэц, эмгэг судлалын дөрөвдүгээр клиникийн эрхлэгч З.Г нь эмчлүүлэгчийг нас барсан болохыг тогтоож, Цэргийн төв эмнэлгийн Эмгэг судлал, шүүх эмнэлгийн цогцос хадгалах газарт хүргүүлсэн байна. Гэвч эмчлүүлэгч амьд болохыг тухайн өдөр Цэргийн төв эмнэлэгт жижүүр хийж байсан Н.Х мэдэж, СЭМҮТ-д буцаан хүргүүлсэн боловч эмчлүүлэгч тухайн өдрөө нас баржээ.

2021 оны 03 дугаар сард эмчлүүлэгч хөлөө гэмтээснийг сэтгэц, эмгэг судлалын гуравдугаар клиникийн сувилагч Л.Б, туслах сувилагч Н.Д нар төвийн удирдлагад мэдэгдэлгүй эмнэлгийн тусламж үзүүлэхээр Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төв рүү авч явсан байна. Энэ талаарх нөхцөл байдлыг тогтоолгохоор цагдаагийн байгууллагад хандсан. Сэтгэц, эмгэг судлалын дөрөвдүгээр клиникийн гэх эмчлүүлэгчийг сандал дээр суулгаж, 2 гарыг нь биеийн ард паартай хүлсэн, мөн өөр

нэг эмчлүүлэгчийг хоёр хүнээр түшүүлж, авч явахдаа хүч хэрэглэсэн гэх тайлбартай эмчлүүлэгчийн хоёр гарын дээд талын булчин хэсэгт хөхөрсөн гэрэл зургуудыг Комисс хүлээн авсан. Гэрэл зургуудад авагдсан нөхцөл байдлын талаар төвийн удирдлагуудын зүгээс тайлбар, нэмэлт мэдээлэл гаргаж өгөөгүй.

СЭМҮТ-д бэлгийн хүчирхийлэл гардаг байж болзошгүй талаар Комиссоос явуулсан өмнөх шалгалтууд анхааруулж байсан. 2018 онд Сэтгэц, эмгэг судлалын гуравдугаар клиникийн эмчлүүлэгч Н-ийг туслах сувилагч Г.Б нь шөнийн цагаар тусгаарлах өрөөнөөс ариун цэврийн өрөөнд авч орж, бэлгийн харьцаанд орсон хэргийг Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс шалгаж, хэрэгсэхгүй болгосон гэх мэдээлэл байна.

2. Хүний эрхийн зөрчлийг хянах, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх талаар төвийн удирдлага зохих арга хэмжээ авахгүй байна. СЭМҮТ-ийн дотоод хяналтын чиг үүрэг бүхий нэгжүүдээс иргэд, эмчлүүлэгчид, эмч, ажилтнуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийгээд дээрх хүний эрхийн зөрчлийг илрүүлэх, хянах, урьдчилан сэргийлэх талаар удирдлага зохих ёсоор ажиллахгүй байна гэж дүгнэлээ. Тухайлбал 2020-2021 онд СЭМҮТ-ийн Ёс зүйн хороогоор хэлэлцсэн асуудлыг шүүж үзэхэд амьд хүнийг цогцос хадгалах газарт шилжүүлсэн, бэртэл авсан эмчлүүлэгчийг ГССҮТ-д зөөвөрлөсөн асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн тухай мэдээлэл байхгүй байна. Ёс зүйн хорооноос 2020 онд 1, 2021 онд 3, нийт 4 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн байх бөгөөд 1 гомдлыг үндэслэлгүй, 2 гомдлыг 2019 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм"-ийг зөрчөөгүй гэж шийдвэрлэж, 1 гомдлыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлжээ. Ёс зүйн хорооноос гадна эдгээр зөрчлийн талаарх мэдээлэл эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийн жагсаалтад мөн тэмдэглээгүй байна.

2021 онд СЭМҮТ-д 20-60 насны 11 эмчлүүлэгч нас барсан болохыг дотоод бүртгэлд тэмдэглэсэн байх бөгөөд 5 эмчлүүлэгчийг эмгэг судлалын шинжилгээнд оруулж, тураал, бүдүүн гэдэсний түгжрэл, цус эргэлтийн цочмог хямрал, тэжээлийн дутагдал, бөөрний сувганцарын тархмал үхжил гэсэн оношоор нас барсныг баталгаажуулжээ. Нэг эмчлүүлэгчийг онош батлуулахаар эмгэг судлалын шинжилгээнд оруулахгүй гэсэн тэмдэглэгээ хийж, 5 эмчлүүлэгчийн оношийг батлуулсан эсэх талаар мэдээлэл байхгүй байна. 2021 оны 07 дугаар сард эмчлүүлэгч Э бусдад боолгосон байдалтай нас барсан гэх мэдээллийн мөрөөр Комисс Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын гуравдугаар хэлтсээс 2019-2021 оны хугацаанд СЭМҮТ-ийн эмчлүүлэгч гадны нөлөөтэй нас барсан байж болзошгүй тохиолдлын талаарх мэдээлэл авахад нийт 5 дуудлага ирснээс 1 эмчлүүлэгч өвчний учир, 4 эмчлүүлэгч бусад шалтгаанаар нас барсан тул хэргийг прокурорт шилжүүлсэн гэжээ. Эмчлүүлэгч нас барсан талаарх хоёр эх сурвалжийн мэдээлэл нэг мөр биш байгаа нь анхаарал татаж байна.

СЭМҮТ-ийн удирдлага иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгааг хянах үүднээс 2021 оны гуравдугаар улиралд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн байдлыг хянаж үзлээ. Энэ хугацаанд нийт 245 өргөдөл, гомдол иргэдээс хүлээн авсан байх бөгөөд 14 нь буюу 5,7 хувь нь талархал, 26 буюу 10,6 хувь нь санал, 2 буюу 0,8 хувь нь гомдол, 203 буюу 82,9 хувь нь бусад гэжээ. Өргөдөл, гомдлын үнэмлэхүй их хувийг эзэлж байгаа өргөдөл, гомдол нь ямар агуулгатай бөгөөд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тодорхой мэдээлэл, дүн шинжилгээ байхгүй байна.

СЭМҮТ-ийн клиникүүд, амбулаторын хэсгүүдэд хяналтын камер суурилуулсан боловч тодорхой зөрчлийг шалгах шаардлага гарах үед камерын байршлыг

өөрчилсөн, бичлэг хийгээгүй, ажиллагаагүй болсон гэсэн тохиолдол гардаг талаар иргэнээс Комисст мэдээлсэн. Өрөө тасалгааг бүрэн камержуулж, нийт 36 камерын дэлгэцээр өдөр тутмын үйл ажиллагааг бүрэн тасралтгүй хянаж, эмчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авсан гэх боловч камерын дүрс бичлэгийг ямар тохиолдолд, хэний зөвшөөрлөөр ухрааж харах, хуулбарлан авах зэрэг асуудлыг зохицуулсан журам, шийдвэр байхгүй, хараа хяналт сул байгаа нь ажилтан хяналтын камерын бичлэгийг хяналтгүйгээр үзэх, өөрчлөх боломжтой байж болзошгүй байна. Нийтийн орон зайд камер суурилуулах нь гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй арга болохыг тэмдэглэхийн зэрэгцээ бие засах, усанд орох өрөө, тасгуудын унтах хэсэг зэрэг хүний хувийн орон зайд онцгой шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд камерын хяналт бий болгохгүй байх хүний эрхийн шаардлагыг дурдах нь зүйтэй.

Сэтгэцийн эмгэг, хурц солиоролтой эмчлүүлэгчтэй ажиллах нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд эрсдэлтэй хөдөлмөрийн нөхцөл бөгөөд эмнэлэг, үйлчилгээний зөрчлийн бүртгэл хяналтыг сайжруулах нь эмчлүүлэгчийн хооронд, эмчлүүлэгчид ба эмч, ажилтнуудын хооронд гардаг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлүүлэгч амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирох, эрх нь зөрчигдөх, эмч, ажилтнууд аргагүй хамгаалалт хийх, амь нас, эрүүл мэндээ хамгаалах гарцаагүй тохиолдлыг баримтжуулах нэн чухал ач холбогдолтой юм.

3. Асрамжийн болон сэтгэц, эмгэг судлалын клиникт эмчлүүлж байгаа эмчлүүлэгчид хүйтний улиралд агаарт гарах, чөлөөт цагаа идэвхтэй өнгөрүүлэх, мэдээлэл авах боломжгүй байна. СЭМҮТ-ийн клиникүүдийн үйл ажиллагаа, онцлогоос шалтгаалан эргэлт оруулах өдөр, цагийг дотооддоо зохион байгуулж, эмчлүүлэгч нар долоо хоногт 2 удаа ар гэрээсээ эргэлт авахаар зохицуулжээ. Гэвч Ковид-19 цар тахлын үед эмчлүүлэгч нарыг эргэлтээр ирсэн хүмүүстэй биечлэн уулзуулахгүй, харин авч ирсэн хоол, хүнсийг эргэлтийн өрөөнд идүүлдэг, бусад зүйлсийг тухайн клиникийн ажилтан шүүгээнд хадгалж, хэрэгцээтэй үед нь гаргаж өгөх, мөн эмчлүүлэгч эмчийн өрөөн дэх суурин утас, зарим тохиолдолд эмч, ажилтнуудын хувийн утсаар гэр бүлтэйгээ харилцаж байна.

Нэг удаад 550 орчим эмчлүүлэгч тус төвд хэвтэж эмчлүүлдэг ба тэдний тал нь байнга амьдардаг, коронавируст халдвар авахад хүндрэх эрсдэлтэй эмчлүүлэгч нэг дор амьдардаг тул эргэлт, уулзалтыг хязгаарлах бодит үндэслэлтэй. Биечлэн уулзалт хийх боломжгүй болсон эмчлүүлэгчийг ар гэр, ойр дотны хүмүүстэйгээ утас, интернэт холбоогоор гэр бүл, гадаад орчинтой харилцах боломжийг бий болгоход төвөөс санаачлага гаргах шаардлагатай байна. Асрамжийн болон сэтгэц, эмгэг судлалын клиникийн эмчлүүлэгч олон жил, сараар СЭМҮТ-д амьдрах боловч төвийн эмч, ажилтнууд, бусад хүмүүсээс гуйж, 1-2 минут утсаар ярихаас өөр боломжгүй байна. Гадаад орчинтой харилцах нь эмчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдал, эмчилгээ, эмч, ажилтнуудын харилцаанд хөндлөнгийн хяналт тавих боломжийг бий болгодог тул хүний эрхийн талаасаа чухал ач холбогдолтой.

Асрамжийн болон сэтгэц, эмгэг судлалын клиникийн эмчлүүлэгчид зуны улиралд салхинд гардаг боловч 09 дүгээр сараас хойш агаарт гаргаагүй талаар дурдаж байлаа. Энэ талаар “сэтгэцийн эмгэг өөрчлөлттэй эмчлүүлэгч бие, сэтгэлийн доройтолтой, идэвхгүй байдаг тул өглөө босгож дасгал хөдөлгөөн хийлгэх, дэглэм тогтоох боломжгүй, өөрсдөө дургүй байдаг” гэж төвийн эмч, ажилтнууд тайлбарлаж байсан. Клиникийн эрхлэгч нараас баталсан цагийн хуваарийн дагуу эмчлүүлэгч, асруулагч нарын чадамжид тохирсон бие, сэтгэхүйн хөгжлийг сайжруулах үйл ажиллагаа тусгагдаагүй байна. Асрамжийн хоёрдугаар клиник, сэтгэц, эмгэг судлалын дөрөв, зургаадугаар клиникүүд өвөлдөө хүйтэн, маш их даардаг талаар

эмчлүүлэгчид ярьж байв. Комиссоос өмнөх жилүүдэд СЭМҮТ-д хийсэн шалгалтын үеэр энэ асуудал мөн хөндөгдөж байсан юм.

Асрамжийн болон сэтгэц, эмгэг судлалын клиникийн эмчлүүлэгч нарыг нас, хүйс, өвчний байдлаар нь биш, орон нутаг, нийслэлийн дүүрэг зэрэг засаг, захиргааны нэгжид хамаарах байдлаар байршуулсан нь эмчлүүлэгчийн амьдралын чанарыг доройтуулж, эмчилгээний үр дүнг бууруулж, хүний эрхийн зөрчил гарах шалтгаан нөхцөлийг үүсгэдэг байж болзошгүй. Хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийг коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийг тусгаарлан эмчлэх тасаг болгон зохион байгуулж, тус тасагт эмчлүүлж байсан 2 хүүхдийг өөр клиникт шилжүүлэн байрлуулжээ. СЭМҮТ-ийн асрамжийн болон шүүх, сэтгэц, эмгэг судлалын клиникээс бусад клиникүүдэд эмчлүүлэгчийг нас, хүйс, өвчний байдлаар ангилан байршуулах нь хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн байдалд зохицсон өдрийн дэглэм мөрдүүлэхэд дөхөмтэй байж болох юм. Хурц солиорол нь намжсан эмчлүүлэгчийг аль болох богино хугацаанд гэр тасагт шилжүүлж, хэвийн амьдрах боломжийг бүрдүүлэх нь эмчлүүлэгчийн амьдралын чанарыг илт дээшлүүлэхийг мөн анхаарах нь зүйтэй.

4. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдаж, шүүх, сэтгэц эмгэг судлалын клиникт эмчлүүлж, хянан харгалзуулж байгаа 19 өвчтөн тодорхойгүй хугацаагаар эмчлүүлж байна. Шүүх, сэтгэц, эмгэг судлалын клиникт 37 эмчлүүлэгч албадан эмчлүүлж байгаагаас албадан эмчилгээний хугацаа дууссан 6, эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах хугацааг шүүхийн шийдвэрт анхнаасаа заагаагүй 13, гэр бүл нь асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үүргээсээ татгалзах хүсэлтээ илэрхийлсэн 11, гэр бүл, төрөл садангүй 2 эмчлүүлэгч тус тус байна. Албадан эмчлүүлэх хугацааг шүүхийн шийдвэрт заагаагүй, хугацаа заасан ч асран хамгаалах харгалзан дэмжих хүнгүй, холбогдох баримт материал дутуу гэх шалтгаанаар эмнэлгээс гаргахгүй байгаа асуудлыг СЭМҮТ дангаараа шийдвэрлэх боломжгүй, тогтолцооны шинжтэй, хүний эрхийн асуудал юм. Харин төвийн зүгээс гэр бүл нь асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үүргээсээ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу татгалзсан эмчлүүлэгчийг асран хамгаалагчаар тогтоогдож, тэднийг асрамжийн болон боломжтой тохиолдолд гэр клиникт шилжүүлж, хэвийн нөхцөлд амьдрах боломжийг хангах, эрх зүйн байдлыг дээшлүүлэхэд санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна. Түүнчлэн, гэр бүлээс нь асран хамгаалах, харгалзан дэмжих хүсэлтээ илэрхийлсэн 10 эмчлүүлэгчийг гэр бүлд нь өгөхөд холбогдох байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж, хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байна.

5. Асруулагчдын нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн захиран зарцуулалтад СЭМҮТ-ийн удирдлагаас үр дүнтэй хяналт тавихгүй байгаа нь асруулагчдын тэтгэмж эзэндээ бүрэн зарцуулахгүй байх, бусад этгээд завших нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Комиссоос 2011, 2016 онд явуулсан шалгалтаар асруулагчдын нийгмийн халамжийн тэтгэмжид төвийн удирдлага хяналт тавьдаггүй, асруулагчид тэтгэмжээ өөрөө захиран зарцуулдаггүй гэсэн асуудлууд анхаарал татаж байсан. Түүнчлэн энэ талаар 2021 оны 04 дүгээр сард Комисст иргэнээс гомдол ирүүлсний дагуу 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр шалгалт хийсэн. Шалгалтын үеэр асруулагчид "сувилагч, асрамжийн клиникийн дарга асруулагч нарын халамжийн мөнгийг авдаг, 20-50 мянган төгрөгт ойр зуурын зүйлс авч өгч, бусад мөнгийг нь өгдөггүй, мөнгөө нэхэхээр загнаж, тайвшруулах тариа хийдэг" гэх тайлбар өгсөн юм. Энэ талаарх гомдолд холбогдогч, асрамжийн клиникийн эрхлэгч Я.С "...эмчлүүлэгчийн нийгмийн халамж, тэтгэмжийн мөнгө сар бүрийн 15-ны өдөр тэдний

нэрийн дансанд ордог. Нэг сувилагч 4 асруулагчийг хариуцдаг. Асруулагчийн дансанд шилжиж орсон мөнгийг 1-2 хоногийн дотор тухайн асруулагчийг хариуцсан сувилагч банкны картаар нь, халамжийн дэвтэртэй бол итгэмжлэлээр авч, хэрэгцээт хүнс, ариун цэврийн хэрэглэл, бусад шаардлагатай барааг эмнэлгийн ойролцоох хүнс, барааны дэлгүүрээс худалдан авч, сарын хугацаанд цувуулан олгодог" гэх тайлбарыг өгчээ.

Дээрх асуудлыг нягтлан шалгуулахаар Комисс 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 4/597 дугаар албан бичгээр Цагдаагийн Ерөнхий газарт шилжүүлж, тус газраас шалгуулах саналтай Нийслэлийн прокурорын газарт шилжүүлсэн талаар 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1и-3/4752 дугаар албан бичгээр Комисст мэдэгдсэн байна.

Энэ удаагийн шалгалтаар СЭМҮТ-ийн захирал "халамжийн мөнгийг бид захиран зарцуулах эрхгүй, асруулагч нарын ар гэрийн гишүүд мөнгийг авдаг. Ажилтнууд асруулагч нарын авсан хүнс, хэрэгцээний зүйлст нь биечлэн хяналт тавьдаг" гэсэн тайлбар өгсөн. СЭМҮТ асран хамгаалагчаар нь тогтоогдсон асруулагчдын тэтгэмжийн зарцуулалтад хяналт тавих, энэ талаарх гомдлыг шийдвэрлэх дотоод хяналтын үр дүнтэй механизм бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

6. Хөдөлгөөний хязгаарлалттай хүмүүс саадгүй зорчих орчин бүрдүүлэх, эмчлүүлэгчийг тэргэнцэрээр хангах талаар боломжит нөөцийнхөө хэмжээнд үе шаттай арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүс хөдөлгөөний доройтолд орох явдал түгээмэл байдаг ба эдгээр хүмүүс, ахмад настнууд СЭМҮТ-өөс эмчилгээ, үйлчилгээ авах хэрэгцээ, шаардлага өндөр тул хөдөлгөөний хязгаарлалттай хүмүүс төвөөр саадгүй үйлчлүүлэх боломжтой орчинг бүрдүүлэх талаар үргэлжлүүлэн санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна. Амбулаторын нэгдүгээр давхарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настанд зориулсан хана дагуулж бэхэлсэн бариултай, ариун цэврийн өрөөний 1 угаалтуурт бариул суурилуулсан байх боловч тус ариун цэврийн өрөөг цоожилсон байх тул зорилтод бүлгийн иргэд ашигладаг эсэх нь эргэлзээтэй байна.

Сэтгэц, эмгэг судлалын гуравдугаар клиникт хөдөлгөөн нь хязгаарлагдсан эмчлүүлэгч Э-гийн тэргэнцэр хуучирч, дугуй нь эвдэрснээс ойр зуур зорчих, бие засах зэрэг наад захын хэрэгцээгээ хангахад бусдын тусламж, дэмжлэг авах шаардлагатай болж, хүнд нөхцөлд амьдарч байна.

7. Удирдлагын зүгээс эмч, ажилтнуудынхаа санал, шаардлагыг сонсох, тавьсан асуудлыг ажил хэрэгчээр шийдвэрлэх байдал дутагдалтай байна. Эмч, ажилтнуудын цалин, нэмэгдэл хөлс, урамшууллыг олгох, сургаж дадлагажуулах, тэдний ажиллах орчин, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд удирдлагын зүгээс бодитой арга хэмжээ авч байгаа боловч тэдний санал, шаардлагыг сонсох, эмчлүүлэгчийн биед нь халдаж, гэмтэл учруулахаас хамгаалах, зөрчил гарсан тохиолдолд эмч, ажилтнуудын үйлдэл нь аргагүй хамгаалалт, гарцаагүй байдал мөн эсэхийг тогтоох, баримтжуулах байдал дутагдалтай байж болзошгүй байна. Эмч, ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаар "...гэнэтийн, огцом авир гаргасан эмчлүүлэгчийн халдлагад өртсөн тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдээлэх, шалгуулах боломжгүй байдаг. Учир нь ажилгүй болох, хуулийн байгууллагаар шалгуулахаас цаагалах, гарсан эрсдлийн талаар арга хэмжээ авахуулахаар удирдлагад хандахаар өөрсдөө бурууддаг. Эмчлүүлэгчийн зүй бус авир, дайралтад өртсөн эмч, ажилтнуудаа хамгаалах талаар эмнэлгийн удирдлагууд арга хэмжээ авах шаардлагатай" гэж байв. Эмчлүүлэгчид тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх явцад гарсан эмнэлэг, үйлчилгээний зөрчлийн бүртгэлийг 2020 оноос хөтөлж эхэлсэн боловч бүртгэлд гарсан зөрчил, үйл

явдлын талаарх мэдээлэл тодорхой авагддаггүй, зөрчилд холбогдогч эмчлүүлэгч ба эмч, ажилтанд учирсан эрсдэл, хохирлын талаарх мэдээлэл дутагдалтай байна.

СЭМҮТ-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо үйл ажиллагаа явуулдаг албан өрөөг коронавирусын халдвартай тэмцэх ажиллагаанд дайчилсан нь эмч, ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдлэх боломжийг бүрдүүлэхэд сул анхаарч байгаагийн илрэл юм. Сэтгэц, эмгэг судлалын гуравдугаар клиникт сувилагчаар ажиллаж байсан Э.Е ажлаас халсан тушаалыг ажлаас халагдсанаас хойш нэг сарын дараа гаргаж өгсний улмаас тэрээр ажилгүйдлийн тэтгэмж авах боломжгүй болсон тухай мэдээлэл Комисст ирсэн. Энэ талаар иргэн Э.Е тайлбарлахдаа "ажлаас халагдсан тушаалаа авахаар хэдэн удаа удирдлагад хандахад гаргаж өгөөгүй" гэсэн бол төвийн Хүний нөөцийн албаны дарга С.А "... Э.Е ажлаас халагдсан тушаалаа авах гэж огт ирээгүй сарын дараа ирж авсан" гэжээ.

Удирдлагын зүгээс эмч, ажилтнуудад ялгаатай ханддаг талаар ярьж байна. Ажиллах орчин, хөдөлмөрлөх эрхийн талаар шаардлага тавьсан ажилтнуудыг хүнд эмчлүүлэгчтэй клиник руу шилжүүлдэг, мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт болон бусад арга хэмжээнд удирдлагын даалгаврыг үг дуугүй биелүүлдэг хүмүүсийг хамруулдаг гэсэн мэдээлэл ирсэн. Эдгээр мэдээлэл бодитой эсэхийг тогтоох боломжгүй боловч шаардлагад тусгаж, төвийн удирдлагын анхаарлыг хандуулах нь зүйтэй байна.

Шалгалтаар илэрсэн хүний эрхийн зарим зөрчил сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүст чиглэсэн төрийн бодлого, тогтолцооны гажуудлаас үүдсэн байна. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн асрамжийн газар байгуулж, СЭМҮТ-ийг асрамжийн чиг үүргээс чөлөөлөх, сэтгэцийн эмгэгийг анагаах эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнээс гадна сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай хүмүүст туслах нийгмийн зөвлөгөө, үйлчилгээг хөгжүүлэх, сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх орны тоог ялангуяа хөдөө, орон нутагт нэмэгдүүлж, үйлчилгээний ачааллыг бууруулах зэрэг өргөн хүрээтэй бодлого, үйл ажиллагааг багтаасан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний 3 дугаар хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, хүн эрх чөлөөгөө хууль зүйн үндэслэлгүй хасуулахгүй байх боломжийг бүрдүүлэх талаар Комиссоос СЭМҮТ-тэй идэвхтэй хамтран ажиллах болно.

Хүний эрхэм байдал, бусадтай ижил үнэ цэнэ, нэр төрийг хамгаалах нь хүний эрхийн эрх зүйн үндсэн зорилго юм. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно" гэж заасан. Монгол Улс 1974 онд соёрхон баталснаар 1976 оноос тус улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн Иргэний болон Улс төрийн эрхийн тухай Олон Улсын Пакт (ИБУТЭОУП)-ын 2 дугаар зүйлийн 1, 3, 7, 17, 26 дугаар зүйлд хүн бүрийн тэгш байдал, ялгаварлан гадуурхахаас хамгаалуулах, нэр төрөө хүндэтгүүлэх, хүн ёсоор харьцуулах эрхийг баталгаажуулжээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлд "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ" гэж заасан. Монгол Улс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцид 2008 онд нэгдэн орж, конвенциор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүднээс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг баталсан. Энэхүү олон улсын гэрээ болон хуулиар сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нэр төр, бусадтай адил тэгш эдлэх хүний эрх, эрх чөлөөгөө хүндэтгүүлэх эрхийг мөн баталгаажуулсан байна.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1991 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 46/119 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийг хамгаалах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зарчмууд”-ыг СЭМҮТ үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллах нь хүний эрхийг хангахад чухал ач холбогдолтой. Ялангуяа, сэтгэцийн эмгэгтэй хүн нэр төр, эрхэм зэргээ хүндэтгүүлж, хүнлэг ёсоор эмчилгээ үйлчилгээ авах, аюулгүй байдлаа хангуулах (1 дүгээр зарчмын 2 дахь хэсэг, 9 дүгээр зарчим), эдийн засгийн болон бэлгийн мөлжлөг, бие махбодын болон бусад хүчирхийлэл, доромжлон харьцахаас хамгаалуулах (1 дүгээр зарчмын 3 дахь хэсэг), аль болох ердийн амьдралтай ижил орчинд эмчлүүлэх (3, 7 дугаар зарчим), зовиур шаналал хамгийн бага мэдэрч, эрүүл мэндийн байдал, ёс заншил, шашин шүтлэгтээ нийцсэн байдлаар эмчлүүлэх (2, 8, 10 дугаар зарчим), хувийн нууцаа хүндэтгүүлэх, мэдээлэл авах, чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлэх, аль болох сайн дурын үндсэн дээр, өөрөө зөвшөөрч эмчилгээ, үйлчилгээ авах (6, 11 дүгээр зарчим, 13 дугаар зарчмын 1(b), 1(c), 2 дугаар хэсэг) зарчмуудыг биелүүлэх шаардлагатай.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд СЭМҮТ-д хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Эмчлүүлэгчийн болон эмч, ажилтнуудын амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд эрсдэл учирсан тохиолдол бүрийг нарийн тодорхой бүртгэж, баримтжуулах, гэм бурууг тогтоох, гэм буруутай хүнд хариуцлага тооцох, зохистой арга хэмжээ авахад чиглэсэн дотоод хяналтыг сайжруулах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах;

2. Хөдөлгөөнтэй, хурц солиоролтой эмчлүүлэгчийг номхотгохдоо “Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд хэрэглэх тусгаарлах болон номхотгох аргын жагсаалт, тэдгээрийг хэрэглэх журам”-ыг чанд мөрдөх, энэ талаарх сургалтыг эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад явуулах;

3. Сэтгэц, эмгэг судлалын болон асрамжийн клиникийн эмчлүүлэгчид агаарт гарах, чөлөөт цагаа үр дүнтэй, хөдөлгөөний идэвхтэй өнгөрүүлэх, мэдээлэл авах боломжийг аль болох дээд хэмжээнд хангахуйц өдрийн дэглэм баталж, мөрдүүлэх, боломжтой тохиолдолд эмчлүүлэгчдийг эрүүл мэндийн байдал, нас, хүйс зэрэг амьдралын нөхцөл, эмчилгээний хэрэгцээнд үндэслэсэн байдлаар байршуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг судалж үзэх;

4. Иргэний үнэмлэхгүй, үүнийхээ улмаас нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид хамрагддаггүй эмчлүүлэгчдийг бичиг баримжуулах ажлыг нэн даруй зохион байгуулах. Энэ ажилд Комиссоос холбогдох эрх бүхий байгууллагад албан хүсэлт гаргах замаар дэмжлэг үзүүлэх боломжтой;

5. Шаардлагатай тохиолдолд эмчлүүлэгчид ар гэрийнхэнтэйгээ интернэт ашиглан, дуу-дүрсний дамжуулалттай харилцах боломжийг бүрдүүлэх, төвийн нөхцөл байдалд зохицсон хэлбэрээр хэрэглээнд нэвтрүүлэх;

6. Сэтгэцийн хурц солиорол нь арилсан, СЭМҮТ-д удаан хугацаагаар эмчлүүлэгчийг аль болох богино хугацаанд асрамжийн тасаг, гэр тасаг зэрэг хүний ердийн амьдралд ойр орчинд шилжүүлэх бодлого баримтлах, боломжтой эмчлүүлэгчдийг шилжүүлэх;

7. Асруулагчдын нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн зарцуулалтад хяналт шалгалт хийх, цаашид хяналт тавих горим бий болгох. Энэ талаар Комиссоос СЭМҮТ-д хууль зүйн зөвлөгөө өгч, боломжит шийдлийг тодорхойлоход хамтран ажиллах боломжтой;

8. Нэг оронд хоёр хүн хэвтэж эмчлүүлэх байдлыг таслан зогсоох;

9. Халаалт муу, хүйтэн өвөлждөг тасгуудын дулааныг нэмэгдүүлэх боломжит арга хэмжээ авах;

10. Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрлөх, эвлэлдэн нэгдэх эрх, сурч боловсрох, албан тушаал ахих боломж, нөхцөлийн талаар эмч, ажилтнуудынхаа санал бодлыг аливаа төрлийн хяналт, дарамтаас ангид байдлаар сонсох арга хэмжээ авах, дүгнэлт хийх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА